LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 2 Viêm kết mạc

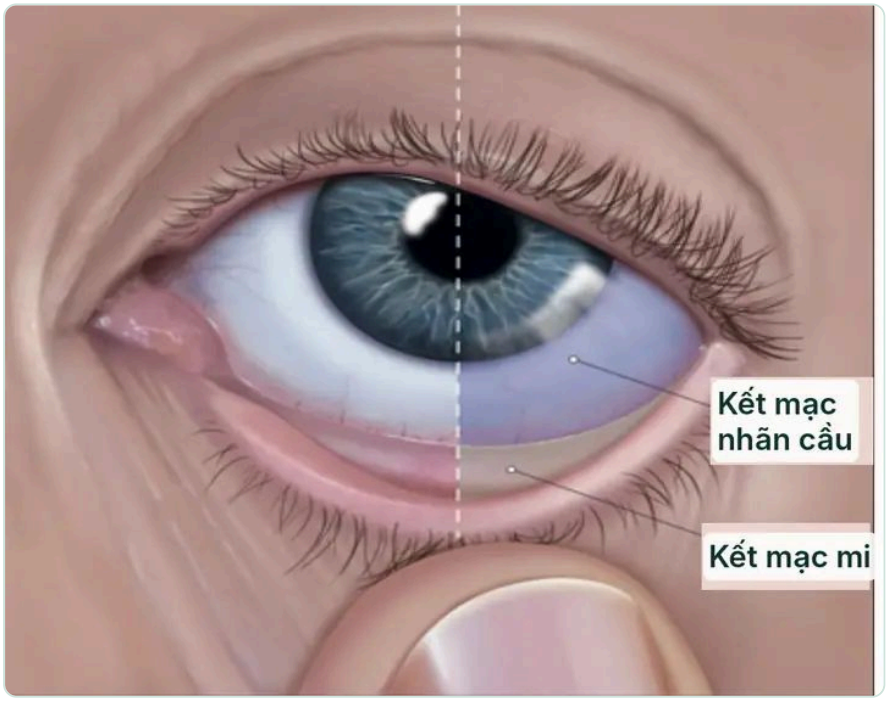
Biên soạn lại từ bài giảng 2. Conjunctivitis - Diagnosis & Treatment.pdf (20 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 7 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU, MÔ HỌC VÀ CHỨC NĂNG KẾT MẠC
2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CHẨN ĐOÁN
3. TRIỆU CHỨNG
4. VIÊM KẾT MẠC DO VI KHUẨN
5. VIÊM KẾT MẠC DO VIRUS
6. VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG
7. BẢNG PHÂN BIỆT NHANH

Học xong bài này, bạn cần: nhận diện các tổn thương lâm sàng của kết mạc; chẩn đoán và điều trị theo từng nguyên nhân; biết cách phòng bệnh và tránh lây lan.

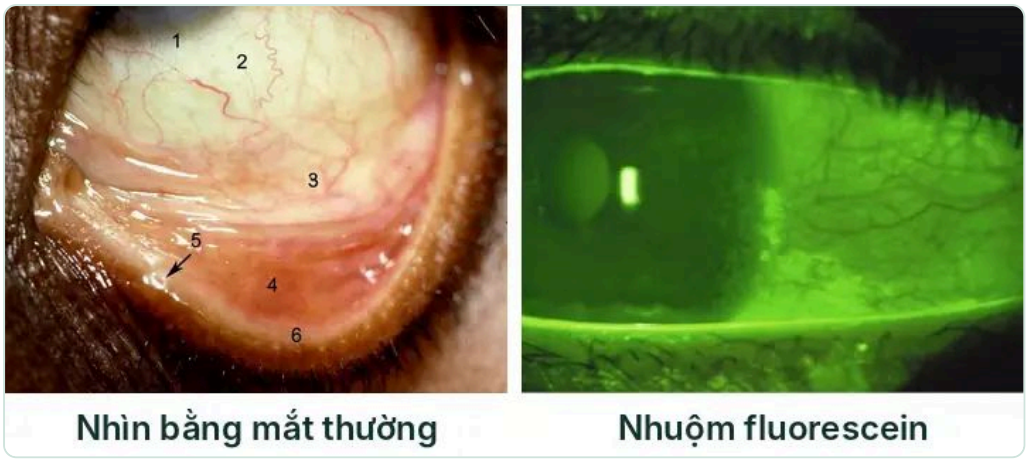
1. GIẢI PHẪU, MÔ HỌC VÀ CHỨC NĂNG KẾT MẠC

- Kết mạc là một **màng nhầy mỏng, trong suốt**, trải từ **rìa giác – củng mạc** đến **chỗ nối da – niêm của mi mắt**.
- Gồm 3 phần nối liền nhau:
  - **Kết mạc nhãn cầu:** phủ lên lòng trắng (củng mạc).
  - **Kết mạc cùng đồ:** chỗ gấp nếp giữa nhãn cầu và mi.
  - **Kết mạc mi:** lót mặt trong của mi mắt.



Hình 1. Kết mạc nhãn cầu phủ lòng trắng, kết mạc mi lót mặt trong mi; kéo mi dưới xuống sẽ thấy rõ cả hai.

Hiểu nhanh: hãy hình dung kết mạc như một **chiếc túi trong suốt** bọc mặt trước nhãn cầu rồi lật ngược lên lót mặt trong mi. Vì là túi kín, dịch tiết và vi trùng dễ ứ lại ở **cùng đồ**, và vì lớp màng trong suốt nên khi mạch máu bên dưới giãn ra, ta thấy ngay mắt đỏ.

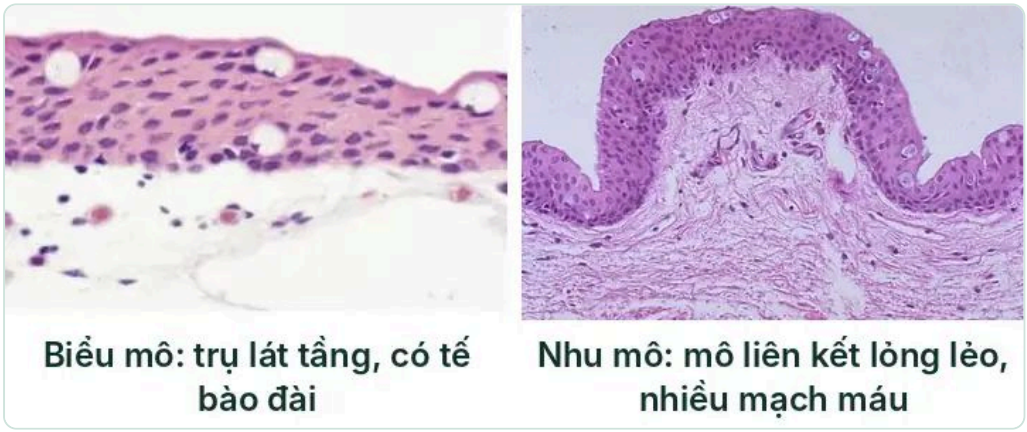


Hình 2. Kết mạc khi quan sát bằng mắt thường (trái) và khi nhuộm fluorescein dưới ánh sáng xanh (phải).

- **Cấp máu: động mạch mi** và **động mạch mi trước**, bắt nguồn từ **động mạch lệ** và **động mạch mũi** của mi mắt.
- **Dẫn lưu tĩnh mạch:** tĩnh mạch kết mạc → **tĩnh mạch mi** → tĩnh mạch cơ.
- **Thần kinh chi phối:** nhánh **V1 và V2** của dây thần kinh sinh ba.

Mô học

- **Biểu mô: 5 lớp tế bào trụ lát tầng, không sừng hóa**.
  - Xen kẽ **tế bào đài** → tiết **chất nhầy**.
  - Khoảng gian bào chứa **kháng thể**.
- **Nhu mô: mô liên kết lỏng lẻo, giàu mạch máu**; chứa nhiều **tuyến lệ phụ Krause và Wolfring**.



Hình 3. Mô học kết mạc: lớp biểu mô có tế bào đài (trái) nằm trên lớp nhu mô lỏng lẻo, nhiều mạch máu (phải).

Chức năng

- **Bảo vệ:** hàng rào ngăn vi sinh vật xâm nhập bề mặt nhãn cầu.
- **Bôi trơn:** sản xuất **chất nhầy** và **nước mắt** (tuyến lệ phụ).
- **Bảo vệ miễn dịch:** giám sát và đáp ứng miễn dịch tại bề mặt nhãn cầu.

> **Vì sao kết mạc dễ viêm?** Nó tiếp xúc trực tiếp với môi trường (bụi, phấn hoa, vi trùng, tay dụi mắt) và có **nhu mô rất giàu mạch máu, tế bào miễn dịch**. Chỉ cần một kích thích nhỏ, mạch máu giãn ra và tế bào viêm kéo đến: đó chính là viêm kết mạc.

2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CHẨN ĐOÁN

- Viêm kết mạc là **bệnh rất thường gặp** trong nhãn khoa.

- Bản chất: **giãn các mạch máu kết mạc** → tập trung **tế bào viêm và chất xuất tiết**.
- **Ba nguyên nhân chính: vi khuẩn, virus, dị ứng**.
- Theo thời gian: **cấp tính ≤ 3 tuần**, **mạn tính > 3 tuần**.
- **Chẩn đoán** dựa vào một hoặc nhiều yếu tố:
  - **Lâm sàng là chủ yếu.**
  - **Soi tươi, nhuộm Gram, Giemsa.**
  - **Nuôi cấy + kháng sinh đồ** (khi nặng, kéo dài, không đáp ứng điều trị).

3. TRIỆU CHỨNG

Cơ năng

- **Đỏ mắt, không đau, không giảm thị lực** – đây là "bộ ba" điển hình.
- Sưng nề mi; **ngứa, rát, nóng** trong mắt.
- Chảy nước mắt hoặc **chất tiết**.
- Nếu **biến chứng lên giác mạc**: **đau nhức, cộm xốn, cảm giác dị vật, mờ mắt**.

> **Lưu ý:** viêm kết mạc đơn thuần **không làm mờ mắt**. Khi bệnh nhân bắt đầu đau, sợ sáng, nhìn mờ là bệnh đã lan vào **giác mạc** – cần khám chuyên khoa.

Thực thể: chất tiết gợi ý nguyên nhân

Chất tiết	Gợi ý nguyên nhân
Dạng nước	**Virus** hoặc **dị ứng**
Dạng nhầy	**Khô mắt** hoặc **dị ứng mạn tính**
Dạng mủ	**Vi khuẩn**



Hình 4. Ba dạng chất tiết: nước trong, nhầy dai và mủ đặc (ở trẻ sơ sinh, mủ nhiều cần nghĩ tới lậu cầu).

Thực thể: các tổn thương trên kết mạc

- **Phù kết mạc:** kết mạc phồng mọng như bọng nước.
- **Sung huyết kết mạc:** mạch máu giãn, đỏ rực.
- **Phản ứng nang:** các hạt nhỏ, tròn, trong như hạt sương ở kết mạc mi – hay gặp trong **viêm do virus**.
- **Xuất huyết dưới kết mạc:** mảng máu đỏ tươi.



Hình 5. Phù kết mạc, sung huyết kết mạc, phản ứng nang và xuất huyết dưới kết mạc.

- **Phản ứng nhú:** các gai nhỏ, đỏ, có lõi mạch máu ở giữa, làm kết mạc mi sần như nhung – hay gặp trong **viêm do vi khuẩn và dị ứng**.
- **Màng kết mạc:** lớp màng trắng phủ trên kết mạc (màng giả bóc dễ, màng thật bóc chảy máu).
- **Sẹo kết mạc:** di chứng của viêm kéo dài.
- **Phản ứng hạch lympho:** sờ thấy **hạch trước tai**, hạch dưới hàm.



Hình 6. Phản ứng nhú, màng kết mạc, sẹo kết mạc và vị trí các hạch lympho vùng mắt.

Mẹo nhớ: nang → virus; nhú → vi khuẩn hoặc dị ứng; hạch trước tai → nghĩ ngay Adenovirus.

4. VIÊM KẾT MẠC DO VI KHUẨN

Triệu chứng cơ năng

- **Cấp tính, thường bị 2 mắt**: có thể 1 mắt bị trước, **1–2 ngày sau lan sang mắt còn lại**.
- **Chất tiết dạng mủ**, **dính mi khi thức dậy buổi sáng**.
- Có thể kèm triệu chứng toàn thân khi nhiễm **lậu cầu, não mô cầu**...

Triệu chứng thực thể (tùy mức độ nhiễm trùng)

- **Sưng nề mi** (rõ khi nhiễm **lậu cầu**).
- **Thường gặp phản ứng nhú**, ít gặp phản ứng nang.
- Có thể kèm **tổn thương biểu mô giác mạc**.
- Có thể có **màng giả** và **màng thật**.

Điều trị

- Bệnh **tự hồi phục dần sau 1–2 tuần**. Nếu điều trị đúng, **khỏi sau khoảng 1 tuần**, đồng thời **giảm tái phát và giảm lây nhiễm** trong cộng đồng.
- **Kháng sinh phổ rộng:** Gentamycin, Tobramycin, Ciprofloxacin, Ofloxacin...
  - **Thuốc nhỏ: 4–6 lần/ngày.**
  - **Thuốc mỡ: 1–2 lần/ngày, trước khi ngủ.**

> **Vì sao dùng thuốc mỡ buổi tối?** Thuốc mỡ lưu lâu trên mắt nhưng làm nhìn mờ, nên dùng lúc đi ngủ là vừa giữ thuốc suốt đêm, vừa không ảnh hưởng sinh hoạt.

5. VIÊM KẾT MẠC DO VIRUS

Adenovirus

- Có **4 thể**:
  - Viêm kết mạc **sốt – họng – hạch**.
  - Viêm **kết – giác mạc thành dịch**.
  - Viêm kết mạc có **phản ứng nang cấp không đặc hiệu**.
  - Viêm kết mạc **mạn**.
- Có thể biến chứng **viêm giác mạc chấm nông** (thường **sau 2 ngày**), **thâm nhiễm dưới biểu mô**.

Herpes simplex virus (HSV)

- **Nguyên phát** hoặc **thứ phát**.
- **Tương đối nhẹ**, **trừ ở trẻ sơ sinh**.
- Sang thương điển hình trên **da mi**, kèm viêm kết mạc, **viêm loét giác mạc**, viêm màng bồ đào... **Hiếm khi xảy ra đơn thuần.**
- **Đa số bị 1 mắt.**

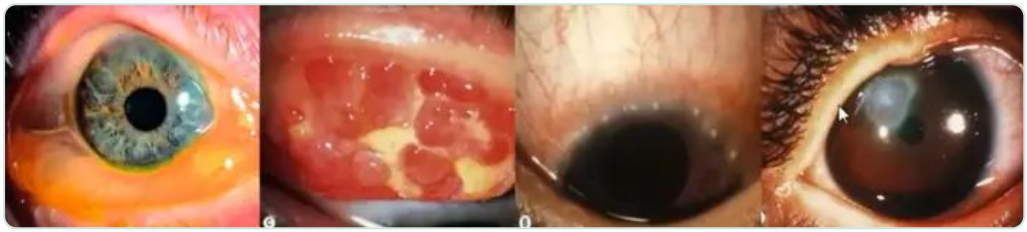
Điều trị viêm kết mạc do virus

- **Giữ vệ sinh mắt**, **tránh lây lan cộng đồng** (rửa tay, không dùng chung khăn).
- **Điều trị triệu chứng**, nâng cao sức đề kháng.
- **Kháng sinh chỉ dùng để ngừa bội nhiễm.**
- **Thuốc kháng virus không hiệu quả** (với viêm do Adenovirus).
- **Corticoid liều thấp:** hạn chế đáp ứng miễn dịch quá mức, nhưng **phải cân nhắc kỹ** khi dùng.

> **Vì sao không cho kháng sinh để "diệt" virus?** Kháng sinh không tác động lên virus; nó chỉ có ích khi lo **bội nhiễm vi khuẩn**. Bệnh do Adenovirus tự giới hạn, việc quan trọng nhất là **không để lây** cho người khác.

6. VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG

- **Cơ năng: 2 mắt**, **ngứa** (triệu chứng nổi bật), đỏ, sưng, chảy nước mắt, **chất tiết trong**; có **tiền căn dị ứng**.
- **Thực thể:** sưng phù mi, phù kết mạc, **phản ứng nhú kết mạc**; có thể tổn thương giác mạc; **không có phản ứng hạch**.



Hình 7. Viêm kết mạc dị ứng: mi và kết mạc phù nề, kết mạc mi có nhiều nhú.

- **Điều trị:**
  - **Hạn chế tiếp xúc dị nguyên**; **chườm lạnh**.
  - **Tại chỗ:** nước mắt nhân tạo; **kháng histamin, co mạch, ổn định dưỡng bào**; corticoid.
  - **Toàn thân: kháng histamin uống**.

7. BẢNG PHÂN BIỆT NHANH

Đặc điểm	Vi khuẩn	Virus (Adenovirus)	Dị ứng
Số mắt	Thường 2 mắt (cách nhau 1–2 ngày)	Bắt đầu 1 mắt rồi lan	2 mắt
Triệu chứng nổi bật	Mủ, dính mi buổi sáng	Chảy nước, cộm, lây thành dịch	**Ngứa**
Chất tiết	Mủ	Nước	Nước trong / nhầy
Phản ứng	Nhú	**Nang**	Nhú
Hạch trước tai	Ít gặp	**Có**	**Không**
Điều trị chính	Kháng sinh phổ rộng	Vệ sinh, triệu chứng	Tránh dị nguyên, kháng histamin

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 2. Conjunctivitis - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.